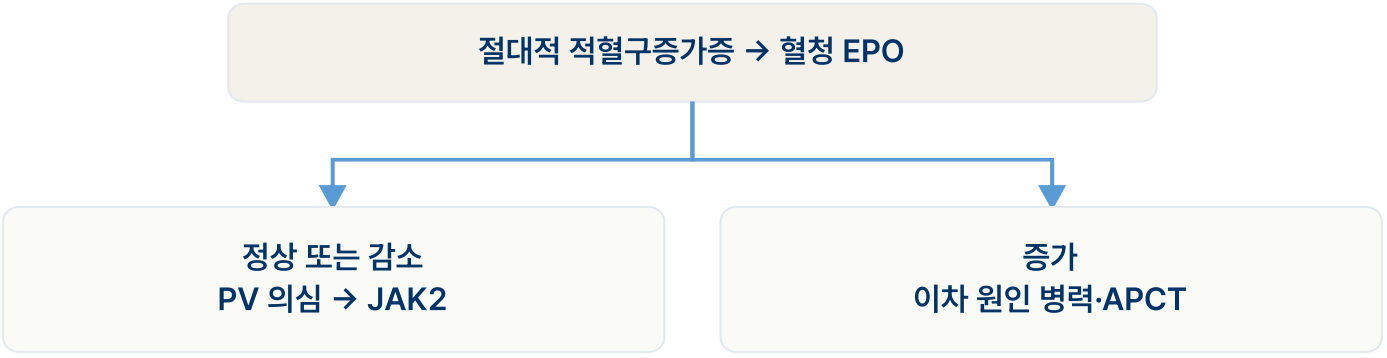
혈색소 상승
탈수·이차 원인·PV 나누기

본강의 적혈구증가증 정의: 남자 Hb >16.5 · 여자 >16.0 g/dL



먼저 상대적 증가인지 확인

장정결 등으로 탈수되면 혈장이 줄어 Hb가 일시적으로 높아질 수 있습니다. 검진 전후 CBC와 추적 결과를 비교합니다. 실제 적혈구가 늘어난 절대적 증가증은 일차성(PV)과 이차성으로 나눕니다.

이차성 원인 병력

구분	진료 중 확인할 내용
저산소증	흡연, 수면무호흡(OSA), 심폐질환(right-to-left shunt 포함), 고산지대 거주. 저산소증 후 EPO 증가.
EPO 분비 종양	간세포암(HCC), 신세포암(RCC), 자궁근종 등. 원인이 뚜렷하지 않으면 복부 CT(APCT) 또는 복부초음파 고려.
그 밖의 원인	남성호르몬(testosterone) 투여, 신장이식 후 적혈구증가증.

진성적혈구증가증(PV) 평가

검사 · EPO가 정상 또는 감소하면 JAK2 유전자검사, 필요시 골수검사로 평가.

진단기준의 구성 · 남자 Hb >16.5 g/dL 또는 Hct >49%, 여자 Hb >16.0 g/dL 또는 Hct >48%; 골수 panmyelosis; JAK2 V617F 또는 exon 12 변이(~98%). 소기준: EPO 감소. 강의 표기: Major 3 또는 Major 2 + Minor 1.

동반 단서 · 백혈구·혈소판도 함께 증가할 수 있음. 손의 발적·저림·통증·가려움, 찬물 샤워 후 가려움 등을 함께 질문.

SGLT2 억제제 복용자의 Hb 상승을 만났을 때

최은지 연자 Q&A · 약 전후 CBC·흡연·상승 추세를 함께 판단

최은지 연자 Q&A · 약 전후 CBC·흡연

SGLT2 억제제 복용 시 EPO 상승에 의한 경미한 적혈구증가증이 생길 수 있습니다. 복용 전후 CBC를 비교해 상관관계를 확인하는 것이 중요하다고 답했습니다. 흡연도 강력한 원인입니다. 먼저 금연 후 CBC를 추적하고, 경미한 상승이 지속되면 약의 적응증과 이득을 고려해 유지 여부를 정하는 것이 합리적이라고 답했습니다. 현저히 높거나 금연 후에도 더 상승하면 PV 배제가 필요할 수 있습니다.

의뢰·검사에 대한 연자 Q&A

구분	진료 중 확인할 내용
유의한 상승	Hb 18.5 g/dL 정도라면 이차성 원인 평가와 함께 EPO·JAK2 V617F 검사를 고려하도록 권유.
지속·상승 추세	뚜렷한 이차 원인 없이 남자 Hb ≥16.5, 여자 ≥16.0 g/dL가 지속되거나 상승 추세면 혈액내과 의뢰 고려.
낮은 정상 EPO	다른 증상이 없더라도 이차 원인이 분명하지 않으면 JAK2 검사 권유. PV 환자의 약 1/3에 비장비대가 동반되어 최근 복부초음파도 참고.

원인에 따른 치료 방향 · 본강

구분	진료 중 확인할 내용
이차성	원인 제거: 금연·OSA 평가 및 CPAP 등. 사혈의 이득은 불분명하다고 설명. 신장이식 후 ACE 억제제/ARB가 일부 도움.
PV	저용량 aspirin·사혈이 기본. Hydroxyurea, ropeginterferon α-2b, ruxolitinib를 소개.

최은지 연자 Q&A · PV 사혈

PV의 사혈 목표 hematocrit은 45%라고 답했습니다. 혈전 병력이 있으면 엄격히 유지하고, 사혈 빈도가 높으면 세포감소 치료를 추가한다고 설명했습니다.